Documento de origen: Tx CACU.pdf

E	Para efectuar una estadificación se debe contemplar el tamaño tumoral, la infiltración a parametrios, extensión a pared vaginal, extensión a pared pélvica, evaluación ganglionar así como, enfermedad a distancia.	**2++** **NICE** *Hricak H, 2005*
E	Otros estudios que pueden ser considerados en el estudio de la paciente con CaCu incluyen: Colposcopia, legrado endocervical, histeroscopía, cistoscopía, recto-sigmoidoscopia, urografía excretora, radiografía de tórax, serie ósea metastásica o gamagramma óseo, resonancia magnética (RM), tomografía axial computarizada (TAC), tomografía por emisión de positrones (PET CT), si es que se cuenta con el recurso.	**2++** **NICE** *Wiebea E, 2012*

Imagen 1/20: Tx_CACU.pdf-0013-03.png

R	El reporte histopatológico de la pieza quirúrgica describirá: Histerectomía: • Descripción macroscópica: tipo de histerectomía, simple, extrafascial, radical. Presencia o no de rodete vaginal. Tamaño del cérvix, tamaño y localización del tumor. Extensión del tumor a la cavidad uterina • Diagnóstico: tipo histológico • Porcentaje de invasión al estroma cervical • Presencia de permeación linfovascular • Estado del borde quirúrgico (si es positivo especificar si es a in situ o a invasor) • Presencia o ausencia de infiltración parametrial • Informar si hay presencia de ganglios parametriales y estatus de estos • Informar si existe infiltración en ganglios pélvicos o paraórticos	**C** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*

E	El tratamiento de la paciente con carcinoma in situ del cérvix será conservador o definitivo de acuerdo a los deseos de paridad.	**2+** **NICE** *Wong A, 2016*
R	En pacientes con paridad no satisfecha pueden ser tratadas con cono cervical, siempre y cuando la paciente sea susceptible de seguimiento.	**C** **NICE** *Wong A, 2016*
E	Las complicaciones del cono cervical se presentan del 7-20%. • Hemorragias: 5-10 %. • Estenosis cervical: 1-4 % • Infecciones: 1 %.	**2++** **NICE** *Rubio D, 2004*
✓	Ante el diagnóstico de cáncer cervicouterino, no existe indicación de tratamiento ablativo.	**Punto de buena práctica**

E	El riesgo de ganglios pélvicos positivos en estadio IA1 con invasión linfovascular es de 1-2%. El riesgo de recurrencia de cáncer en este estadio es de menos del 2%.	**4** **NICE** *Holman L, 2014*
R	Quedará a criterio del centro oncológico especializado el efectuar la linfadenectomía correspondiente dado el bajo porcentaje de metástasis a ganglios ó traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
R	En etapas microinvasoras el porcentaje de invasión a ganglios paraaorticos es de cero, por lo que no se justifica efectuar linfadenectomía paraaortica.	**2B** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
E	El ganglio centinela puede ser considerado como una estrategia aceptable en pacientes en etapa temprana.	**1++** **NICE** *Kadkhodayan S, 2015*

R	Se sugiere realizar como tratamiento quirúrgico de elección histerectomía radical PIVER III o Tipo C, más disección de ganglios pélvicos y paraaorticos.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
E	En mujeres pre menopaúsicas se prefiere realizar transposición (pexia) ovárica fuera del campo de radioterapia con fines de preservación hormonal.	**4** **NICE** *Ghadjar P, 2015*
R	En pacientes que no son candidatas a cirugía debido a comorbilidades o mal estado funcional, se recomienda teleterapia y braquiterapia.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*

Documento de origen: Tx CACU.pdf

	Pacientes con contraindicación a QT pueden recibir RT sola.	**Punto de buena práctica**

Imagen 6/20: Tx_CACU.pdf-0024-06.png

Documento de origen: Tx CACU.pdf

E	En las pacientes en estadio IIB el porcentaje de ganglios paraaórticos positivos es de 16 al 21% y en etapa IIIB en 25-31%.	**1+** **NICE** *Wiebea E, 2012*
E	Un estudio realizado en 2004 que evaluó el resultado de 600 pacientes con cáncer cervico-uterino etapa IB2 sometidas a histerectomía radical, 28% tuvieron ganglios positivos, 79% invasión al tercio externo del estroma cervical, 6 pacientes tuvieron margen vaginal positivo y 5 extensión parametrial, todos estos factores ameritan la adición de tratamiento adyuvante.	**2+** **NICE** *Yessaian A, 2004*
R	Por lo anterior la cirugía no es una opción, debiendo ser el tratamiento con base en radioterapia y quimioterapia concomitantes.	**B** **NICE** *Yessaian A, 2004*

Imagen 7/20: Tx_CACU.pdf-0024-12.png

E	Yamashita en 2010 comparó el resultado del tratamiento con cirugía seguido por RT adyuvante contra Quimio/Radioterapia concomitante. La sobrevida global a 3 años fue de 80 contra 75.1% respectivamente, sin embargo la tasa de complicaciones grado 3-4 fue de 12% para QT/RT y de 26% para el grupo de cirugía más RT adyuvante.	**2+** **NICE** *Yamashita H, 2010*
E	El empleo de Quimio/Radioterapia concomitante comparado con Radioterapia sola resulta en: • Aumento del 6% en sobrevida a 5 años (HR 0.81, p=<0.001). • Hubo aumento significativo en sobrevida para ambos grupos de Quimioterapia basada en platinos (HR 0.83, p=0.017) y no basada en platinos (HR 0.77, p=0.009). Se disminuyó también la recurrencia local y a distancia así como la sobrevida libre de progresión.	**1+** **NICE** *Chemoradiotherapy for Cervical Cancer Meta-Analysis Collaboration (CCCMAC), 2008* **1+** **NICE** *Chemoradiotherapy for Cervical Cancer Meta-analysis Collaboration (CCCMAC), 2010*
E	La braquiterapia es un componente esencial del tratamiento del cáncer de cérvix localmente avanzado, permite alcanzar una dosis mayor de radiación al cérvix, evitando el tejido sano adyacente.	**1+** **NICE** *Han K, 2013*
E	Puede ser administrada mediante baja tasa de dosis (0.4 a 2Gy por hora), alta tasa de dosis (>12Gy por hora) o tasa de dosis pulsada (Se utiliza alta tasa de dosis para simular baja tasa). El empleo de braquiterapia resulta en un aumento en la sobrevida cáncer específica (64 vs 52%) y la sobrevida global (58 vs 46%) a 4 años.	**4** **NICE** *Viswanathan A, 2012* **4** **NICE** *Lee L, 2012*
E	El empleo de alta o baja tasa de dosis tiene la misma eficacia y complicaciones tardías.	**2++** **NICE** *Lertsanguansinchai P, 2004* *Liu R, 2014*
E	La braquiterapia de baja tasa de dosis requiere una o dos inserciones y puede iniciar cerca del final o al terminar la Teleterapia. La braquiterapia de alta tasa de dosis puede iniciarse en cuanto se alcance una reducción del tamaño tumoral que permita una adecuada distribución de la dosis.	**4** **NICE** *Viswanathan A, 2012* *Lee L, 2012*

R	Todas las pacientes que reciban Quimioterapia/Radioterapia concomitante deben concluir el tratamiento dentro de las primeras 8 semanas.	**D** **NICE** *Lee L, 2012*
E	Aunque estudios anteriores han demostrado la importancia de concluir de forma oportuna el tratamiento con radioterapia sola, hay datos limitados cuando se emplea Quimioterapia/Radioterapia concomitante. Song et al, en 2012 demostró que aumentar el tiempo de tratamiento a más de 56 días se asocia a tasas más altas de progresión de la enfermedad dentro de la pelvis (26 vs 9%, HR 2.8 95% IC 1.2-16). Sin embargo no fue un factor significativo para progresión de la enfermedad a distancia o mortalidad cáncer-específica.	**2+** **NICE** *Song, S, 2013*
E	El nivel de hemoglobina contribuye también al pronóstico de la paciente. Haensgen en 2005 demostró que los pacientes con un nivel de hemoglobina <11g/dL tenían una sobrevida a 3 años de 27%, comparado con 62% para aquellos con hemoglobina ≥11g/dL (p=0.006).	**4** **NICE** *Höckel M, 2005*
E	La planeación del tratamiento con radioterapia externa está basada en tomografía (3D) se considera el estándar para el tratamiento con teleterapia. El volumen de tratamiento debe incluir la enfermedad macroscópica, parametrios, ligamentos útero-sacros, margen vaginal que cubra la enfermedad macroscópica, ganglios presacros y volúmenes ganglionares en riesgo dependiendo del estado ganglionar determinado de forma quirúrgica o radiográfica.	**1** **ESMO** *Colombo N, 2012*
E	Puede usarse Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) para minimizar la dosis a órganos de riesgo en el contexto post-histerectomía o cuando se necesite tratar ganglios paraaórticos. Se recomienda su uso en centros con experiencia en la técnica.	**1** **ESMO** *Colombo N, 2012*
E	La American Brachytherapy Society menciona que para el tratamiento con alta tasa de dosis el fraccionamiento más utilizado es 5 fracciones de 6Gy, sin embargo también son aceptados otros fraccionamientos con dosis equivalente biológica en el rango antes mencionado dependiendo de la experiencia de cada Centro Hospitalario.	**1** **ESMO** *Colombo N, 2012*

R	Se recomienda radioterapia externa (teleterapia) 45-50.4Gy a pelvis más braquiterapia. Es recomendable valorar el incremento de dosis 10 a 15Gy a los ganglios linfáticos afectados de forma macroscópica, utilizando técnicas conformales 3D.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
✓	Cuando no se cuente con sistemas de planeación basados en tomografía, pueden emplearse técnicas bidimensionales (2D) siempre y cuando se asegure la correcta cobertura de los volúmenes de tratamiento.	**Punto de buena práctica**
R	Se recomienda el uso de radioterapia de baja tasa de dosis o su equivalencia biológica en alta tasa de dosis, de acuerdo a la disponibilidad de cada Centro Hospitalario. Asimismo, es recomendable utilizar braquiterapia 3D guiada por imagen en los centros que tengan experiencia con la técnica y que cuenten con el recurso disponible.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016* **B** **Secretaría Técnica AUGE MINSAL** *Ministerio de Salud. Guía Clínica Cáncer Cervicouterino, 2015*
R	La dosis de Braquiterapia depende del tamaño tumoral posterior a la teleterapia: • Si hay respuesta completa o el residual es menor de 4cm, la dosis total teleterapia/braquiterapia recomendada a punto A es ≥80Gy • Para pacientes que no responden o con residual mayor de 4cm al momento de la braquiterapia, la dosis total a punto A es de 85-90Gy.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016* **B** **Secretaría Técnica AUGE MINSAL** *Ministerio de Salud. Guía Clínica Cáncer Cervicouterino, 2015*
R	Se recomienda que la técnica de aplicación intracavitaria o intersticial, dependa de la elección del médico, así como de las consideraciones anatómicas de cada paciente. No se recomienda el uso de Radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o de Radioterapia estereotáctica (SBRT) como alternativas al empleo de braquiterapia.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*

E	Se ha informado por estudios que la supervivencia para pacientes con recurrencia ganglionar es de 24 semanas y recurrencia visceral de 12 semanas.	**1++** **NICE** *Friedlander M,2002*
E	Se ha observado que la recurrencia se presenta a ganglios retroperitoneales representan el 81%, supraclaviculares 71%, pulmonares 7% hepáticas o carcinomatosis 8% y óseas 16%.	**1++** **NICE** *Friedlander M,2002*
E	La finalidad de la quimioterapia en estas pacientes es paliativa con el objetivo de disminuir síntomas y mejorar la calidad de vida, sin generar morbilidad.	**1** **ESMO** *Colombo N, 2012*
E	Las pacientes con estadio IVB tiene un a sobrevida global de 9% a 5 años, por lo general son candidatas a quimioterapia sistémica o radioterapia paliativa para el control de sus síntomas.	**1** **ESMO** *Colombo N, 2012*

R	El tratamiento en etapa IVB es con quimioterapia con cisplatino y la radioterapia puede considerarse para control pélvico de la enfermedad o pacientes sintomáticas (sangrado transvaginal o dolor pélvico).	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
E	Hay múltiples fármacos que se relacionan con tasas de respuesta objetiva; no obstante, las respuestas duraderas son poco frecuentes. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento del cán estadio IVB y su respuesta se mencionan a continuación: • Paclitaxel/cisplatino 46% • Cisplatino/gemcitabina 41% • Ifosfamida 31% • Cisplatino/topotecan 27%	**4** **NICE** *Verma J, 2016*
E	Al parecer no existe evidencia de terapia alguna que permita curación de pacientes en esta etapa. No obstante, a menudo es necesario paliar el dolor o el sangrado vaginal y mejorar la calidad de vida.	**3** **Secretaría Técnica AUGE MINSAL** *Ministerio de Salud. Guía Clínica Cáncer Cervicouterino, 2015*
R	De acuerdo a las condiciones de la paciente se puede considerar las siguientes opciones terapéuticas: ▪ Enfermedad locorregional o a distancia resecable: o Resección más radioterapia o terapia ablativa local ± RT o RT/QT concomitante. También puede asignarse QT paliativa. ▪ Enfermedad locorregional o a distancia no resecable: o Quimioterapia o terapia de soporte.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
✓	La paciente en etapa IV B tendrá que ser sometida a un comité multidisciplinario para identificar la mejor opción terapéutica.	**Punto de buena práctica**
R	Las intervenciones paliativas deben basarse en las necesidades de la paciente y de su familia, más que en un plazo de supervivencia esperada. (*Ver GPC IMSS-440-11. Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativo, 2010).*	**D** **NICE** *IMSS-440-11. Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativo, 2010*
✓	Se sugiere brindar a la paciente toda la información de forma clara sobre las condiciones y efectos de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar y así poder solicitar al mismo tiempo el consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos.	**Punto de buena práctica** *IMSS-440-11. Guía de Práctica Clínica en Cuidados Paliativo, 2010*

E	Para el tratamiento de la recurrencia locorregional se debe tomar en cuenta: - Antecedente de cirugía sin radioterapia - Quimioradioterapia previa - Antecedente de radioterapia radical	**4** **NICE** *Verma J, 2016*
E	El tratamiento de las pacientes que recibieron RT de acuerdo al sitio de la enfermedad recurrente: ▪ Enfermedad central no mayor a 3 cm: • Excenteración pélvica + RT intraoperatoria si cuenta con el recurso ▪ En pacientes con tumor ≤ 2 cm: • Histerectomía radical o valorar reirradiación bajo protocolo. ▪ Enfermedad periférica: • A considerar cirugía vs quimioterapia seguidas de radioterapia local. • A considerar radioterapia sola. • Dependerá de las condiciones locales de la lesión.	**Nivel Bajo con experiencia clínica apropiada** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
R	En pacientes sin radioterapia previa, considerar resección quirúrgica si es posible, más RT ± QT basada en platino ± braquiterapia. Si se presenta recurrencia: ensayo clínico de QT.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
E	La enfermedad persistente posterior a tratamiento sistémico y/o recurrente metastásica es susceptible de ser tratada localmente cuando puede ser resecada (hígado, pulmón, cerebro) cuando por clínica e imagen no existe evidencia de enfermedad en otros sitios. Cuando hay múltiples lesiones en cerebro o en hueso lo indicado es radioterapia.	**Nivel Bajo con experiencia clínica apropiada** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*

E	En una serie de 29 casos de resección de metástasis pulmonares en cáncer cervico-uterino reportaron intervalo libre de enfermedad de 42 meses, supervivencia libre de enfermedad a 5 años de 32.9% y se identificaron en el análisis multivariado como factores pronóstico de resecabilidad menos de 2 metástasis, variedad histológica epidermoide el intervalo libre enfermedad fue mayor a 12 meses.	**2+** **NICE** *Yamamoto K, 2004*
R	La resección de metástasis puede ser considerada en casos seleccionados con menos de 2 lesiones, variedad epidermoide intervalo libre de enfermedad mayor a 12 meses.	**2** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*
R	Está indicada la quimioterapia posterior a cirugía en las metástasis hepáticas y pulmonares.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
E	En la paciente que presenta metástasis óseas la media de sobrevida es de 10 meses, y el tratamiento con radioterapia provee paliación del dolor, sin mejorar el pronóstico.	**2+** **NICE** *Yoon A, 2013*
E	La media de sobrevida en pacientes con metástasis ósea tratada con radioterapia ± quimioterapia es mejor que la quimioterapia sola (12 vs 7 meses).	**2+** **NICE** *Yoon A, 2013*
R	En toda paciente con antecedente de cáncer cervico-uterino que durante su vigilancia se observe por imagen lesión única a distancia sospechosa de metástasis, es recomendable analizar el caso en sesión conjunta para seleccionar los casos que son susceptibles de tratamiento quirúrgico.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
R	El tratamiento sistémico con citotóxicos en enfermedad recurrente o persistente, se recomienda sea similar al manejo proporcionado en etapa clínica IVB.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network (NCCN), Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*

R	Los estudios de rayos x sólo se recomiendan en casos de sospecha de enfermedad localmente avanzada con mandil abdominal de protección.	**D** **NICE** *Russa M, 2016*
E	La resonancia magnética sin contraste es el mejor estudio para determinar la extensión local de la enfermedad así como la presencia de ganglios linfáticos.	**4** **NICE** *Russa M, 2016*
R	En paciente con adenocarcinoma o estadio localmente avanzado debe considerarse realizar ultrasonido pélvico y resonancia magnética.	**2** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*
E	La tomografía axial computada y la tomografía con emisión de positrones están contraindicadas en el embarazo.	**1** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*
R	La paciente necesita de orientación cuidadosa para tomar la decisión de interrumpir el embarazo o continuarlo, así como para postergar o recibir el tratamiento durante la gestación y sincronizar la resolución del embarazo. Información que se recomienda esté registrada en el expediente clínico.	**2** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*

R	Los 5 criterios que rigen el tratamiento de cáncer cervicouterino en el embarazo son: • Etapa clínica (tamaño tumoral) • Edad gestacional • Estadio de ganglios linfáticos • Subtipo histológico • Deseo de la paciente de continuar el embarazo.	**1** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*
R	Se recomienda realizar los procedimientos quirúrgicos a partir del 2° trimestre del embarazo solamente en caso necesario.	**D** **NICE** *Amant F,2014*
E	Tratamiento sin deseo de preservar del embarazo: EC IA1: Cono cervical. EC IA2 a IB1: histerectomía radical + LPB sin deseo de fertilidad (<24 SDG), traquelectomía radical + LPB con deseo de fertilidad. IB2 o >: Evacuación uterina en primer trimestre, 12- 14 SDG (histerotomía).	**4** **NICE** *Russa M, 2016*
E	El límite para considerar preservación del embarazo, la edad gestacional recomendada es: mayor de 24 SDG. En embarazos del primer trimestre se tiene que contemplar la terminación del embarazo aun con deseo de preservación.	**4** **NICE** *Russa M, 2016*
E	Tratamiento con deseo de preservar embarazo: EC IA1 a IB1: Cono cervical. EC IB2 o >: quimioterapia neoadyuvante (> 1 trimestre)y posterior resolución del embarazo al documentarse madurez pulmonar.	**4** **NICE** *Amant F,2014*
E	La edad gestacional apropiada para realizar la linfadenectomía pélvica es de 22 a 24 SDG. Cuando está indicada disección ganglionar pélvica puede ser por laparotomía o laparoscopia, dependiendo de la técnica que elija el cirujano y el recurso del centro oncológico.	**4** **NICE** *Russa M, 2016* **4** **NICE** *Amant F,2014*

E	En un estudio en donde se valoró la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante durante el embarazo, el cual se mantuvo hasta la semana 33,2 en promedio y las respuestas fueron las siguientes: Respuesta completa: 6,25% Respuesta parcial: 62.5% Enfermedad estable: 28,1%, Progresión de la enfermedad: 3,1%.	**4** **NICE** *Amant F,2014*
E	El riesgo de teratogénesis en el primer trimestre es de 7 a 17 % con cisplatino y 25 % en terapia combinada. Durante el segundo y tercer trimestre el riesgo de malformaciones se aproxima al de la población general 3%.	**4** **NICE** *Russa M, 2016* **2** **GRADE** *Primer consenso nacional de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino, 2014*
R	La terminación del embarazo es por vía abdominal.	**4** **NICE** *Russa M, 2016*

	El tratamiento para tumores mayores a IA1 sin infiltración linfovascular se recomienda observación y vigilancia con revisión clínica ginecológica. Para estadios IAI con infiltración linfovascular o IA2 se recomienda parametrectomia, vaginectomia del tercio superior, linfadenectomía pélvica bilateral y muestreo de ganglios paraaorticos. En estadios mayores y/o márgenes son positivos o los estudios de imagen reportan ganglios linfáticos negativos la quimio-radioterapia concomitante a base de cisplatino con o sin braquiterapia individualizada.	**Nivel Bajo con experiencia clínica apropiada** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN), *Clinical Practice Guidelines in Oncology*,2016
	En etapa Ib1 se podría realizar la cirugía apropiada para la etapa y considerar factores pronóstico de acuerdo a los criterios de Sedlis y Peters o valorar radio-quimioterapia concomitante.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN), *Clinical Practice Guidelines in Oncology*,2016

	La vigilancia se llevara a cabo con la exploración física en cada consulta, citología anual, colposcopia cuando se cuente con el recurso. Los estudios de imagen (TT, TC, PET, RM) están indicados con presencia de síntomas o hallazgos clínicos de sospecha de recurrencia. La revisión clínica se efectúa: • Cada 3-6 meses los 2 primeros años. • Del tercero al quinto año cada 6-12 meses. • Después del 5° año revisión anual, aunque hay que individualizar el riesgo de recurrencia en cada paciente.	**2A** **NCCN** *National Comprehensive Cancer Network* (NCCN), *Clinical Practice Guidelines in Oncology,2016*
	Individualizar cada caso y realizar estudios de imagen únicamente cuando los síntomas o los hallazgos clínicos lo justifiquen.	**Punto de buena práctica.**

Documento de origen: Tx CACU.pdf

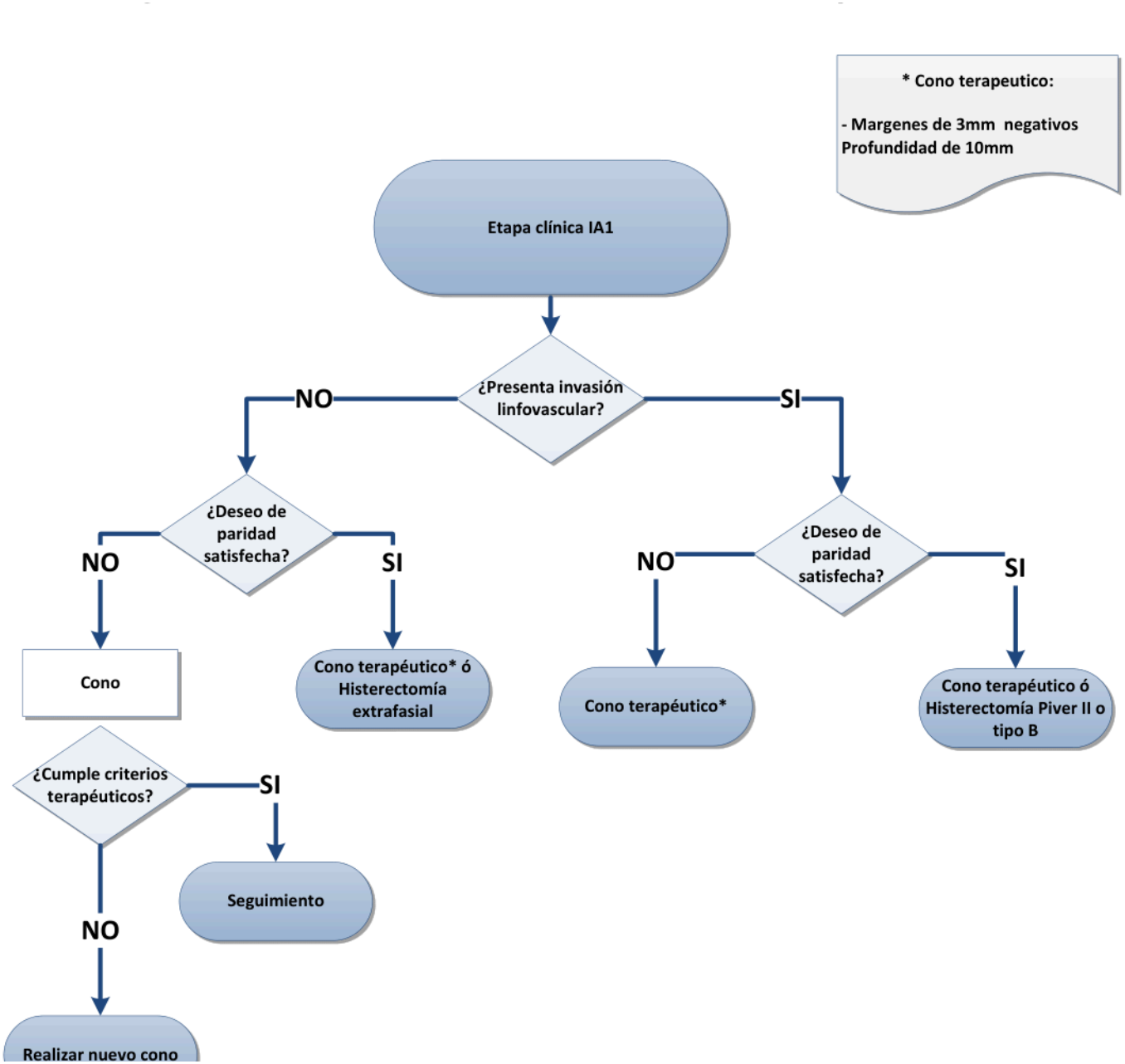


Imagen 20/20: Tx_CACU.pdf-0049-03.png